

Gestão de Serviços de Farmácia

Flávia Deffert

Aula 01

Gestão de Serviços
Farmacêuticos: contextualização,
conceitos, competências e
atividades.



Diretor Executivo
DAVID LIRA STEPHEN BARROS

Diretora Editorial
ANDRÉA CÉSAR PEDROSA

Projeto Gráfico
MANUELA CÉSAR ARRUDA

Autor
EDUARDO NASCIMENTO DE ARRUDA

Desenvolvedor
CAIO BENTO GOMES DOS SANTOS

Autora

FLÁVIA DEFFERT

Olá. Meu nome é Flávia Deffert. Sou formada em farmácia pela Universidade Federal do Paraná onde, também, cursei mestrado em Ciências Farmacêuticas. Após o mestrado, pude experimentar atividades administrativas e à docência. Como experiência profissional, trabalhei na FUNTEF no setor de compras – licitações, conhecimento que depois pude aplicar na atividade como farmacêutica na FUNEAS. Atuava na direção técnica dessa fundação que é responsável pela gestão administrativa de uma série de hospitais do Estado do Paraná. Na FUNEAS, realizei atividades relacionadas a seleção, programação e aquisição de produtos para saúde, insumos e medicamentos. Para auxiliar nessas atividades, iniciei uma Pós-Graduação lato senso em Gestão por processos e da qualidade e outra em Gestão de Serviços de Saúde, ambas na FAE Business School. Também, atuei como professora de farmacotécnica e elementos de farmacologia para o curso de farmácia e para o curso técnico em podologia, na UnC Mafra/SC e FAFILTEC Curitiba. Assim, pude perceber o quanto eu adoro exercer a minha profissão e, assim, poder transmitir conhecimento e as minhas experiências para você, que está iniciando a sua profissão. Por isso fui convidada pela Editora Telesapiens a integrar seu elenco de autores independentes. Estou muito feliz em poder ajudar você nesta fase de muito estudo e trabalho. Conte comigo!

Iconográficos

Olá. Meu nome é **Manuela César de Arruda**. Sou a responsável pelo projeto gráfico de seu material. Esses ícones irão aparecer em sua trilha de aprendizagem toda vez que:



INTRODUÇÃO:
para o início do desenvolvimento de uma nova competência;



NOTA:
quando forem necessários observações ou complementações para o seu conhecimento;



EXPLICANDO MELHOR:
algo precisa ser melhor explicado ou detalhado;



SAIBA MAIS:
textos, referências bibliográficas e links para aprofundamento do seu conhecimento;



ACESSE:
se for preciso acessar um ou mais sites para fazer download, assistir vídeos, ler textos, ouvir podcast;



ATIVIDADES:
quando alguma atividade de autoaprendizagem for aplicada;



DEFINIÇÃO:
houver necessidade de se apresentar um novo conceito;



IMPORTANTE:
as observações escritas tiveram que ser priorizadas para você;



VOCÊ SABIA?
curiosidades e indagações lúdicas sobre o tema em estudo, se forem necessárias;



REFLITA:
se houver a necessidade de chamar a atenção sobre algo a ser refletido ou discutido sobre;



RESUMINDO:
quando for preciso se fazer um resumo acumulativo das últimas abordagens;



TESTANDO:
quando o desenvolvimento de uma competência for concluído e questões forem explicadas;

SUMÁRIO

Contextualizando: histórico da instituição hospitalar e sistemas de saúde no Brasil.....	10
Histórico da instituição hospitalar.....	10
Hospital na atualidade.....	13
Saúde pública no Brasil.....	14
Descobrimos a farmácia hospitalar - histórico, conceitos, objetivos, atividades.....	19
Farmácia hospitalar: como surgiu?.....	19
Farmácia Hospitalar: conceitos, objetivos e atividades.....	23
Farmacêutico hospitalar: competências.....	29
Definições em gestão de pessoas.....	30
O papel do farmacêutico hospitalar.....	31
Conhecendo as atividades administrativas e clínicas dos serviços farmacêuticos.....	36
Entendendo as atividades dos serviços de farmácia.....	36

UNIDADE

01

INTRODUÇÃO

Você sabia que a área de gestão de serviços farmacêuticos é um mercado a ser explorado? A farmácia hospitalar é uma unidade administrativa relativamente nova, tendo a sua obrigatoriedade somente na década de 90. Infelizmente, somente nos anos 2000, o governo federal conseguiu "obrigar" que os hospitais e serviços de saúde tivessem uma farmácia que não fosse um mero depósito e repasse de medicamentos, mas, sim, uma unidade de assistência à saúde do paciente. Dessa forma, contribui para otimizar a recuperação a saúde dos pacientes. Além disso, desde 1995, o Ministério da Saúde relata que o custo da assistência farmacêutica é caro e, acredite, essa situação não mudou até hoje. Seja por deficiências na formação do profissional que, geralmente, sai com formação na área clínica, mas não na administrativa. Em um ambiente em que os recursos são escassos e a necessidade e o desejo dos clientes é maior que o disponível, o estudo da gestão dos serviços farmacêuticos visa otimizar a alocação de recursos disponíveis, tendo como foco o paciente, mas sendo economicamente viável. Você sabia que algumas pesquisas demonstram que a simples reacomodação do mobiliário da farmácia pode causar a economia de, até milhões de reais? Legal, não é? As principais responsabilidades do gestor de serviços farmacêuticos são: ser responsável pelas etapas de seleção, programação, aquisição, armazenamento e dispensação de medicamentos e insumos, ser responsável pela manipulação pela terapia de nutrição parenteral, gestão de pessoal, da qualidade e financeira do setor de farmácia do hospital. E, aí? Prontos? Vamos lá.

OBJETIVOS

Olá. Seja muito bem-vindo à Unidade 1 – Gestão de Serviços Farmacêuticos: contextualização, conceitos, competências e atividades. Nosso objetivo é auxiliar você no desenvolvimento das seguintes competências profissionais até o término desta etapa de estudos:

1. Contextualizar o histórico da instituição hospitalar e sistemas de saúde no Brasil;
2. Descobrir a farmácia hospitalar: histórico, conceitos, objetivos, atividades;
3. Aprender as competências do farmacêutico hospitalar;
4. Introduzir as atividades administrativa, técnicas e clínicas do serviço farmacêutico hospitalar.

Assim como Platão no mito da Caverna, o livro de Eclesiastes (é... aquele do antigo testamento) nos traz a mensagem no versículo a seguir que a busca pela sabedoria é a busca pela luz que nos soltam das amarras e protegem a vida.

"A sabedoria é tão boa quanto o patrimônio: é de proveito àqueles que veem o sol; estar sob o abrigo da sabedoria é como estar sob o abrigo do dinheiro, mas é vantagem conhecer a sabedoria, pois ela preserva a vida de quem a possui" (Eclesiastes 7: 11 – 12)

Então? Preparado para uma viagem sem volta rumo ao conhecimento? Ao trabalho!

Contextualizando: histórico da instituição hospitalar e sistemas de saúde no Brasil

INTRODUÇÃO:

Ao término dessa competência você entenderá de que forma o histórico da instituição hospitalar e das mudanças no sistema de saúde no país influenciaram na evolução e no reconhecimento dos serviços farmacêuticos ofertados no estabelecimento hospitalar. Da mesma forma que outras áreas da saúde, como a da saúde mental, com a compreensão da importância dos serviços e a humanização do atendimento ao paciente, os serviços farmacêuticos vêm sendo otimizados e cada vez mais reconhecidos. É importante dizer que o contexto social e político em que a instituição hospitalar se encontra influencia diretamente sob o modo que o estabelecimento é administrado e o serviço é realizado. Por isso é importante que você conheça a história. Faz parte do seu trabalho como gestor de serviços de farmácia reconhecer qual o ambiente esse serviço está se desenvolvendo, quais as ameaças e as fraquezas e quais as oportunidades e forças, e isso está diretamente ligado com o histórico da instituição. Entendeu? Vamos nessa?!



Histórico da instituição hospitalar

Sabia que ter um local específico para a cura e tratamento de doentes não é uma prática nova? Relatos dizem que já no século VI a.C. locais para o isolamento de doentes do restante da comunidade já eram conhecidos. Naquela época as doenças eram intrinsicamente ligadas às fúrias dos deuses. Havia a crença de que as pessoas que faltavam com os deuses no cumprimento de algum sacrifício ou por comportamentos inadequados sob a vista deles recebiam penalidade divina.

Com o passar dos anos (e com o evento das guerras), na Roma Antiga foram criados os primeiros hospitais militares, que ao longo da Idade Média, passaram a introduzir do conceito de assistência social da doença.

A filosofia cristã de amor ao próximo influenciou a fundação do primeiro hospital. Nesse novo contexto, o atendimento hospitalar não

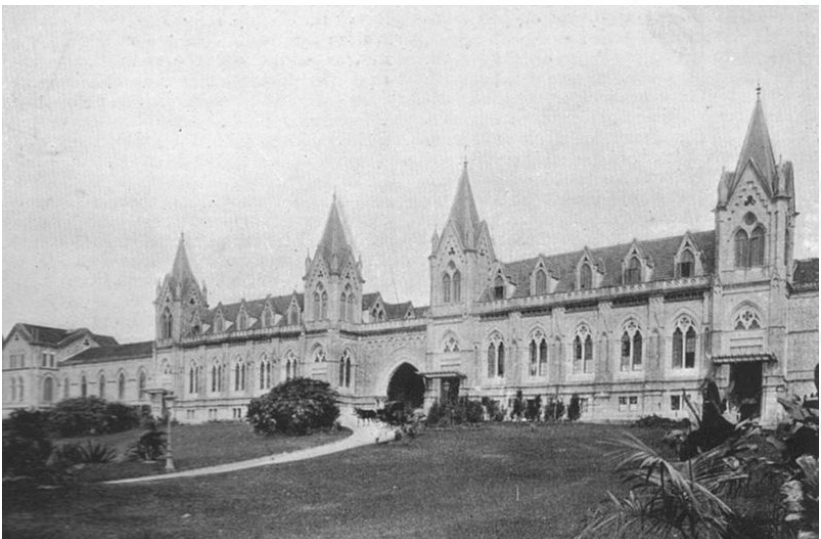
se restringia a, somente, isolar os doentes do restante da população para que não houvesse o contágio às pessoas mais abastadas. Nessa época foram encontradas informações da era hipocrática, Hipócrates é considerado o pai da medicina, que foram vitais para a formação desses novos conceitos em saúde.

Por meio das ordens monásticas, foram criados espaços físicos nos conventos para auxiliar enfermos, idosos e desamparados. Além dessas, outras instituições religiosas ou não religiosas, beneficentes ou não beneficentes, surgiram, são exemplos as Santas Casas de Misericórdia e as Sociedades de Beneficência.

Com o aumento crescente da população carente e enferma, os governos começaram a se organizar e em locais apropriados passaram a acomodar os doentes e concentrar as pessoas que queriam cuidar delas. Assim, surgiram os hospitais cujo nome vem da palavra latina *hospitale* o que significava que, antes de tudo, deveria ser provido um teto, um leito, alimento e a atenção aos necessitados.

O primeiro hospital do Brasil e da América do Sul foi fundado em 1543 – a Santa Casa da Misericórdia de Santos. Já, em São Paulo, o hospital só foi fundado na década de 90 daquele século.

Figura 1: Santa Casa da Misericórdia de São Paulo



Fonte: ©Wikicommons

O modelo hospitalar como conhecemos hoje começou a ser implantado na década de 1930, com a introdução de princípios administrativos específicos à área. Foi em 1933, em Chicago (EUA), que o primeiro curso de administração hospitalar do mundo de modo a demonstrar aos técnicos que não basta ser bom na área técnica da saúde, mas também nas técnicas de gestão.

“Na primeira metade do século XX verifica-se um extraordinário avanço dos conhecimentos sobre a natureza das doenças e, em consequência, a imperiosa necessidade do incremento de novos métodos diagnósticos e terapêuticos, com a indústria construindo novos e sofisticados aparelhos, cujos modelos são rapidamente renovados, obrigando os hospitais, para acompanhar esse ritmo, a se organizarem cada vez mais administrativa e economicamente.” (CAVALLINI e BISSON, 2010).

Atualmente, tem-se como características de um hospital assistir aos pacientes de forma humanizada; ter e manter fontes de informação científica atualizada; pesquisar e empregar novas tecnologias (aprovadas) para o atendimento à saúde; ser um local de ensino para formar novos profissionais; aproximar o hospital da comunidade onde atua; e, estimular a prevenção de doenças.

REFLITA:



Com o aumento populacional, o aumento da complexidade de atendimento e o aumento do custo da tecnologia empregada no atendimento, as instituições hospitalares necessitaram realizar “manobras” para que as contas não fechassem no vermelho. Nesse contexto é fácil pensar em como as instituições particulares terminam o ano com o saldo positivo, mas é difícil pensar em como hospitais e clínicas que trabalham com SUS e planos de saúde conseguem fechar as contas no positivo, com os valores sobre consultas, cirurgias, medicamentos, OPMEs (órteses, próteses e materiais especiais) e exames com valores tabelados e que, por vezes, não cobrem nem o material utilizado. O que você acha que hoje é feito para contornar essa situação? O que pode ser feito?

Hospital na atualidade

Desde então muitas coisas mudaram e a concepção de hospital foi, ao longo do tempo, alterando-se para um local de, de fato, assistência à saúde para a população. A OMS (Organização Mundial da Saúde) define hospital como:

“O hospital é parte do sistema integrado de saúde, cuja função é dispensar à comunidade completa assistência à saúde preventiva e curativa, incluindo serviços extensivos à família em seu domicílio e ainda um centro de formação para os que trabalham no campo da saúde e das pesquisas biossociais.”

Segundo a OMS o hospital apresenta quatro funções: prevenir a doença; restaurar a saúde; exercer funções educativas; e, promover a pesquisa. As configurações mínimas para que o estabelecimento seja considerado um hospital são: possuir seis leitos para pacientes, ocupado por um período superior a 24 horas pelo mesmo indivíduo; ser construído, equipado e mantido para que preste serviços de prevenção, diagnóstico e tratamento dos pacientes internados, dentro das áreas de especialidades, contando com recursos de hotelaria e tecnologia; contar com o apoio de profissionais da saúde habilitados, em quantidade e qualidade compatíveis com as necessidades técnicas, além de pessoal administrativo.

A classificação dos hospitais está resumida na tabela a seguir:

Tabela 1: Classificação das instituições hospitalares quanto ao regimento jurídico, porte, serviço, corpo clínico e entrada dos pacientes

Classificação		Especificação
Regime Jurídico	Público	administração direta ou autarquias e fundações
	Privado	com ou sem fins lucrativos. Sem fins lucrativos são as instituições filantrópicas e as beneficentes.
Porte	Pequeno	Menos de 50 leitos
	Médio	Entre 51 e 150 leitos
	Grande	Entre 150 e 500 leitos
	Especial	Acima de 500 leitos

Tipo de serviço	Geral	Duas ou mais especialidades
	Especializado	Somente uma especialidade
Corpo Clínico	Aberto	os médicos não são necessariamente funcionários da instituição
	Fechado	Apenas os médicos contratados podem atender aos leitos
Entrada dos pacientes	Portas abertas	Entrada pelo pronto atendimento
	Porta fechada	Atendimento ambulatorial ou hospital-dia

Fonte: adaptado de Cavallini e Bisson, 2010

Saúde pública no Brasil

A história da saúde pública no Brasil foi bastante conturbada ao longo da curta história brasileira. Nesse período, menor ainda foi o tempo em que todos os brasileiros puderam ter acesso a saúde.

Durante os primeiros 400 anos de existência, o Brasil não contava com ações integrais de saúde pública. Nesse cenário, somente os que tinham terras e posses podiam arcar com o custo de um atendimento médico e com as medicações da época. Tornando as suas chances de vida maiores que de escravos, imigrantes brancos pobres e índios.

No caso dos últimos, o "diagnóstico" e "tratamento" era feito como de conhecimento popular, por meio do emprego de ervas e de "crendices" populares. É importante lembrar que nessa época a doença era encarada por muitos como um castigo divino.

Ao longo do tempo e do fortalecimento da religião no país, seja ela católica, protestante, pentecostal, espírita ou qualquer outra que tenha como princípio o amor ao próximo, tornou possível a abertura de Santas Casas da Misericórdia no país. Esses locais foram criados e mantidos por meio de doações das comunidades e dessa forma puderam construir o seu patrimônio.

Além disso, desde a época do Império, campanhas de saúde pública limitavam-se a higienização sanitária, tanto para evitar as endemias de febre amarela, peste bubônica, malária e varíola, quanto para "esconder" os pobres da vista dos ricos. De modo geral, pode-se dizer que o período após a independência foi uma reestruturação do saneamento básico.

Já, durante a época da República, sanitaristas como o médico Oswaldo Cruz comandaram companhias de saúde. Uma das campanhas mais conturbadas e conhecidas da nossa história foi a que desencadeou a Revolta da Vacina. Nessa época, Oswaldo Cruz tinha a missão de erradicar doenças endêmicas como varíola, peste bubônica e febre amarela e dentre suas atitudes instituiu a vacinação obrigatória que não foi bem vista pela população que já estava sofrendo pela reforma urbana e sanitária da área portuária do Rio de Janeiro, antiga capital federal.

O movimento sanitarista ainda persistiu durante a ditadura militar. No entanto, nesse momento, o movimento passou a ter uma característica exploratória que foi essencial para a compreensão das transformações necessárias para o atendimento à população.

Em 1920, surgiram as primeiras Caixas de Aposentadoria e Pensão (CAPS), que são mantidos pelos trabalhadores a fim de haver alguma forma de garantia às crianças e aos idosos. Na década de 30, Getúlio Vargas criou os Institutos de Aposentadoria e Pensões (IAPS), que eram divididos por categoria profissional. Em 1966, as IAPS foram fundidas e deram origem ao Instituto Nacional de Previdência Social, englobando todos os empregados com carteira assinada, os quais recebiam assistência médica do INPS, hospitais e ambulatórios médicos. Para oferecer os serviços aos segurados do INPS, em 1974, foi criado o Instituto Nacional de Assistência Médica e Previdência Social (INAMPS).

Enfim, na Constituição Federal de 1988, artigo 6º estabelece em cláusula pétrea que são direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados. Complementa-se a esse artigo, o 196 da CF:

“Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.” (Brasil, 1988)

Em 1990, o Sistema Único de Saúde foi regulamentado por meio da lei nº 8080/1990 e nº 8142/90, além de outras leis e normas, com “finalidade de alterar a desigualdade na assistência à saúde da população, tornando obrigatório o atendimento público a qualquer cidadão, sendo proibidas cobranças de dinheiro sob qualquer pretexto”.

“A rede que compõe o SUS é ampla e abrange tanto ações quanto os serviços de saúde. Engloba a atenção primária, média e alta complexidades, os serviços urgência e emergência, a atenção hospitalar, as ações e serviços das vigilâncias epidemiológica, sanitária e ambiental e assistência farmacêutica” (BRASIL, 2019).
<http://bit.ly/36XpzZC>



SAIBA MAIS:

Para saber mais sobre, consulte o Manual do Ministério da Saúde (1990), lançado para esclarecer o funcionamento desse novo sistema de saúde denominado de ABC do SUS: Doutrinas e Princípios, disponível em: <http://bit.ly/36ZzRbI>. Outro caderno interessante é A gestão do SUS, produzido pelo Conselho Nacional de Secretários da Saúde (Brasil, 2015). Disponível em: <http://bit.ly/2Sd3H8g>

“POR QUE SISTEMA ÚNICO? Porque ele segue a mesma doutrina e os mesmos princípios organizativos em todo o território nacional, sob a responsabilidade das três esferas autônomas de governo federal, estadual e municipal. Assim, o SUS não é um serviço ou uma instituição, mas um Sistema que significa um conjunto de unidades, de serviços e ações que interagem para um fim comum. Esses elementos integrantes do sistema, referem-se ao mesmo tempo, às atividades de promoção, proteção e recuperação da saúde.” (BRASIL, 1990).

As ações e os serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:

- I – Descentralização, com direção única em cada esfera de governo;
- II – Atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais;
- III – participação da comunidade.

O Sistema Único de Saúde será financiado, nos termos do artigo 195, com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes.

Os princípios organizativos do SUS são aqueles empregados para organizar o funcionamento desse sistema. Ao todo são cinco: regionalização, hierarquização, descentralização, comando único e participação popular. Os princípios do SUS são universalização, equidade e integralidade.

DEFINIÇÃO:

Universalização: o acesso à saúde deve ser garantido pelo Estado à TODAS pessoas, independente de sexo, raça, ocupação, características físicas, sociais, nacionalidade ou qualquer outra que possa distinguir uma pessoa de outra.

Equidade: tratar desigualmente os desiguais. O que isso significa? Isso significa que o tratamento às pessoas deve ser diferente e de acordo com as suas necessidades, de modo que, ao fim, as pessoas possam ser consideradas iguais.

Integralidade: o tratamento às pessoas deve ser para elas como um todo, atendendo a todas as suas necessidades. Esse princípio pressupõe uma relação entre a saúde e as demais políticas públicas.



No surgimento do Sistema Único de Saúde também se previu a hipótese de o setor privado complementar o setor público quando houver necessidade. Por isso, vamos conhecer rapidamente o que é o sistema complementar e suplementar.

A saúde complementar é definida quando a iniciativa a desenvolve nos termos do art. 199 da CF, que prevê que as instituições privadas poderão participar de forma complementar ao Sistema Único de Saúde. Devem ser contratadas por meio de contrato de direito público ou convênio, tendo preferência as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos

"A saúde complementar deve ser compreendida, assim, por meio das ações e serviços de saúde que, embora sejam prestadas por pessoas jurídicas de direito privado, são consideradas ações e serviços públicos de saúde em razão da existência de uma relação jurídica específica, concretizada por contratos ou convênios firmados entre essas pessoas jurídicas e a União, os Estados ou os Municípios. Tal relação jurídica possui suas balizas legais traçadas pelo art. 199 (20) da Constituição Federal e pelos artigos 24 a 26 da Lei 8.080/90." (CRP/SP, 2019).

Já, na Saúde suplementar, não há vínculo com o SUS, são os conhecidos planos de saúde. "Representa uma relação jurídica entre prestador de serviço privado de saúde e consumidor, organizada por meio de planos de saúde, conforme previsto nas Leis Federais 9.961, de 28 de janeiro de 2000, e 9.656/1998" (CRP/SP, 2019).



REFLITA:

Desde meados de 2014, a população brasileira vem sofrendo uma diminuição do poder econômico, o que, consequentemente, diminui o poder de aquisição de planos de saúde pela classe média. Assim, houve um inchaço inesperado do sistema público. Nesse contexto surgiram empresas que iniciaram a executar seus trabalhos em um vácuo da legislação. Essas empresas, hoje regulamentadas, oferecem consultas e exames a um valor menor – tabelado – que o praticado na iniciativa privada, facilitando a adesão e o pagamento. Segundo elas, as consultas são em um valor acessível. Pensando no que vimos até agora, você acha que essa é a melhor solução? Qual a sua opinião?

Agora é hora da revisão! Nessa competência vimos o histórico dos surgimentos dos hospitais no mundo e no Brasil. Locais para conter e tratar doentes surgem desde a antiguidade quando a doença era vista como uma punição divina. Ao longo do tempo, com a evolução da ciência, iniciaram-se de fato os atendimentos e os tratamentos. Nessa época os

herbanários, barbeiros, médicos eram responsáveis pelo diagnóstico e pelo tratamento dos pacientes que se limitavam aos de classe alta ou que tinham posses. Ao longo do tempo e com a influência das religiões, principalmente as cristãs, a formação de hospitais para o povo foram ocorrendo. Eram as denominadas Santas Casas da Misericórdia que eram sustentadas exclusivamente por doações. Por fim, estudamos a evolução da saúde pública no Brasil, que se baseou, por muito tempo, em ações de reformas urbanas e ações sanitárias. Isso quer dizer que ações efetivas para tratamento e prevenção continuava alcançando somente os de classes econômicas mais altas e ações coletivas eram realizadas para o restante da população. Ao longo da história, as ações passaram de brasileiros trabalhadores com carteira registrada para todos as pessoas em território brasileiro. O auge da saúde pública brasileira foi em 1988 com a promulgação da Constituição Federal e a regulamentação em 1990 do Sistema Único de Saúde. Pegou? Está pronto para a próxima?

Descobrimos a farmácia hospitalar - histórico, conceitos, objetivos, atividades

INTRODUÇÃO:



Nessa competência iremos conhecer como surgiram os serviços farmacêuticos no âmbito hospitalar e da formação de uma importante figura para o funcionamento de uma farmácia hospitalar: o farmacêutico. Além disso, trabalharemos para lembrar quais os objetivos, funções e atribuições da farmácia hospitalar. Nesse caminho, também, conheceremos alguns órgãos que auxiliam na regulamentação do serviço farmacêutico hospitalar no Brasil e exterior. Espero que você embarque comigo nessa história de sabedoria, conquistas e promoção do bem-estar ao paciente.

Farmácia hospitalar: como surgiu?

Os serviços farmacêuticos em um ambiente hospitalar ou clínico concentram-se na unidade de farmácia hospitalar e na figura do farmacêutico hospitalar. O surgimento da farmácia hospitalar remonta à

época dos gregos, romanos, chineses e árabes, época em que a atuação farmacêutica e de um médico eram uma única figura. No século II, a primeira escola para se tornar "farmacêutico" foi registrada onde hoje é Bagdá, na Arábia Saudita.

Nessa época, o boticário (outros termos também eram empregados para designar a profissão dependendo do local) acumulava as funções de conhecer e curar as doenças e, já naquela época, deveriam cumprir uma série de requisitos e ter uma série de equipamentos para o atendimento e manipulação de medicamentos.

Veja que interessante, até mesmo, na Bíblia pode-se encontrar referências a essas profissões:

"Honra o médico por causa da necessidade, pois foi o Altíssimo quem o criou. Toda a medicina provém de Deus, e ele recebe presentes do rei: a ciência do médico o eleva em honra; ele é admirado na presença dos grandes. O Senhor fez a terra produzir os medicamentos: o homem sensato não os despreza. Uma espécie de madeira não adoçou o amargor da água? Essa virtude chegou ao conhecimento dos homens. O Altíssimo deu-lhes a ciência da medicina para ser honrado em suas maravilhas; e dela se serve para acalmar as dores e curá-las; o farmacêutico faz misturas agradáveis, compõe unguentos úteis à saúde, e seu trabalho não terminará, 8até que a paz divina se estenda sobre a face da terra." (ECLESIASTICO 38:1-8)

Mais tarde, no século XVIII, as profissões foram legalmente separadas houve, inclusive, a proibição de médicos serem donos das boticas. Com o tempo, o nome "farmacêutico" passou a ser adotada e a formação "universitária passou a ser estendida a toda a Europa.

A partir do final do século XIX, com a modernização dos serviços, a farmácia hospitalar passou a ter um enfoque clínico assistencial, atuando em todas as fases da terapia medicamentosa, dedicando-se a promover o uso racional de medicamentos. A farmácia clínica surgiu, então, nos Estados Unidos, tendo como meta principal o uso racional de medicamentos. Assim, o farmacêutico, além de suas atribuições

relacionadas aos medicamentos, passou a desenvolver atividades clínicas voltadas para o paciente.

No Brasil, a história inicia-se com os índios, que da mesma forma que outros povos, empregavam uma série de plantas, animais e minerais, além de próprios rituais, para a cura de enfermidades. Essa cultura passou mais tarde a agregar o conhecimento vindo dos negros em estado de escravidão e dos brancos, especialmente os jesuítas que vieram em missão. Oficialmente foram os jesuítas que abriram as primeiras boticas no país, a pedido da família Real.

A abertura de outras boticas foi cerceada pela Coroa que permitia que, no Brasil, o acesso ao medicamento só aconteceria se nas expedições portuguesas, francesas ou espanholas houvesse um cirurgião barbeiro ou algum tripulante com uma botica portátil cheia de drogas e medicamentos.

Ao longo do tempo, boticas públicas e aqueles presentes em hospitais militares e Santas casas foi aumentando e o acesso à saúde foi se tornando "mais fácil". No século XIX, a botica denominouse farmácia e assumiu grande importância nos hospitais da época, já que fornecia todo o medicamento para o tratamento dos pacientes. Sobre o assunto Simonetti e colaboradores (2009, p.58) discorrem:

"Sua função era dispensar as especialidades farmacêuticas necessárias e disponíveis no mercado, até de manipular remédios, através da preparação de receitas magistrais com a utilização de drogas importadas e produtos de seu herbário, tanto para os indivíduos hospitalizados quanto para aqueles que se encontrava em tratamento ambulatorial."

Avançando algumas centenas de anos, ocorreram guerras mundiais que promoveram o avanço científico e industrial, com avanços significativos na quimioterapia, antibioticoterapia e imunoterapia. Isso mudou o modo de tratamento e de consumo de medicamentos, que passaram a ser industrializados. A partir de 1920, com a expansão da indústria farmacêutica, as farmácias hospitalares transformaram-se em áreas de armazenamento e distribuição dos medicamentos produzidos pelas indústrias.

Após a década de 1940, com o surgimento dos antibióticos, os farmacêuticos começaram a perceber a necessidade da ampliação de sua área de atuação no ambiente hospitalar, retornando à prática farmacêutica na área da farmácia hospitalar/clínica.

Em 1950, no Brasil, os serviços de farmácia hospitalar, representados pelas Santas Casas de Misericórdia e hospitais-escola, desenvolveram-se e modernizaram-se. A regulamentação da profissão no Brasil se deu apenas em 1960, por meio da Lei federal 3.820 de 11 de novembro de 1960, pelo presidente Juscelino Kubitschek.

A partir de 1975 a disciplina de farmácia hospitalar passou a fazer parte da formação, grade curricular do farmacêutico, e, a partir de 2005, foi aprovada a residência na área de farmácia hospitalar.

Em 1973, a lei nº 5.991/1973 estabeleceu que toda farmácia (inclusive a hospitalar) deveria possuir um farmacêutico responsável técnico. Infelizmente, alguns hospitais e até mesmo drogarias negaram a necessidade, pois já tinham em seus quadros de funcionários os dispensários. A lei demorou um pouco "para pegar", assim, em 2002, a Portaria GM/MS nº 1017, tornou explícita a obrigatoriedade de um farmacêutico responsável técnico, formado em cursos aprovados pelo MEC e inscritos no CRF, para o funcionamento de farmácias comunitárias, hospitalares e magistral.

Importante destacar os papéis que os Conselhos federais e estaduais de farmácia apresentam nesse contexto; bem como, ao da Sociedade Brasileira de Farmácia Hospitalar e Serviços de Saúde que auxiliaram na normatização e fixação de padrões mínimos de qualidade para a boa prestação de serviço, segurança para o paciente e boas condições de trabalho para todos os envolvidos nos processos da farmácia hospitalar.

Ainda assim, apesar de todo o esforço, ainda hoje a implantação de serviços farmacêuticos de qualidade é penosa. Muitas vezes, no ambiente hospitalar, a figura do médico é "endeusada", focando as forças da administração para agradá-lo. Em segundo lugar, aos enfermeiros e técnicos de enfermagem que contemplam a maior parte da mão de obra do hospital. E dessa forma, o papel e a identidade dos outros profissionais da saúde torna-se minimizada.

Outras possibilidades também dizem respeito a própria formação do farmacêutico que não possui o conhecimento técnico suficiente para as suas funções e para os assuntos pertinentes nas comissões hospitalares.

Por fim, como qualquer corpo físico, as instituições também sofrem com a 1ª lei de Newton – a da inércia. Apesar das forças com vetores de força momento apontarem para o sentido do movimento (F_a), outros, em número muito maior, vem em sentido contrário (F_b), anulando as forças e fazendo com que a direção da força de movimento continue na direção F_b .

Figura 2. Representação esquemática do conflito entre mudanças e costumes



Fonte: Elaborada pela autora (2019)

Farmácia Hospitalar: conceitos, objetivos e atividades

Até agora vimos uma breve revisão do surgimento da farmácia hospitalar no Brasil. Agora, veremos quais são os conceitos, objetivos e atividades por trás dessa unidade dentro da instituição hospitalar.

Segundo a SBRAFH (2017), a definição de farmácia hospitalar é:

“A farmácia de hospitais, clínicas e estabelecimentos congêneres é uma unidade clínica, administrativa e econômica, dirigida por farmacêutico, ligada hierarquicamente à direção do hospital, adaptada e integrada funcionalmente com as demais unidades administrativas e de assistência ao paciente” (SBRAFH, 2017).

Os serviços farmacêuticos hospitalares têm o objetivo de realizar o conjunto de atividades farmacêuticas, exercidas em organismos hospitalares ou a outros serviços a ele ligados. A unidade de farmácia hospitalar, apesar de subordinada à estrutura hierárquica do hospital, deve apresentar autonomia técnica e científica para a realização de suas atividades.

Esses serviços são os que asseguram a terapêutica medicamentosa aos doentes, a qualidade, eficácia e segurança dos medicamentos, promovendo integração entre as equipes de cuidados à saúde e promovendo ações de investigação científica e de ensino. As responsabilidades e funções dos serviços farmacêuticos hospitalares, no que diz respeito aos medicamentos, produtos farmacêuticos e dispositivos hospitalares, abrangem as seguintes áreas: seleção, aquisição, recepção, armazenagem, preparação, controle, distribuição, informação, farmacovigilância, farmacocinética e farmácia clínica.

Em 1997, a primeira resolução do Conselho Federal de Farmácia (nº 300) foi publicada. Nela temos a descrição dos objetivos e das principais atividades da farmácia hospitalar. Para essa resolução, a farmácia hospitalar é definida como a unidade clínica de assistência técnica e administrativa, dirigida por um farmacêutico, integrada funcional e hierarquicamente às atividades hospitalares.

A Autoridade Nacional de Medicamentos e Produtos de Saúde de Portugal (Infarmed) descreve como a principal função da farmácia hospitalar é garantir a qualidade da assistência prestada ao paciente por meio do uso seguro e racional de medicamentos e correlatos, de modo a adequar sua aplicação à saúde individual e coletiva com a finalidade assistencial, preventiva, docente e investigativo. Para que os serviços farmacêuticos sejam cumpridos, deve-se contar em número suficiente para a realização da atividade (INFARMED, 2005).

Com o intuito de orientar o serviço farmacêutico hospitalar, esse órgão publicou, em 2005, o Manual da Farmácia Hospitalar.



ACESSE:

Acesse o Manual da Farmácia Hospitalar, disponível em:
<http://bit.ly/2Q2Y61E>

As competências da farmácia hospitalar na área da assistência são:

- Assumir a coordenação técnica nas discussões para seleção e aquisição de medicamentos, germicidas e correlatos, garantindo sua qualidade e a eficácia da terapia medicamentosa.

- Cumprir normas e disposições gerais relativas a armazenamento, controle de estoque e distribuição de medicamentos, correlatos, germicidas e materiais médico-hospitalares.

- Estabelecer um sistema eficiente e seguro de dispensação para pacientes ambulatoriais e internados, de acordo com as condições técnicas do hospital onde se efetive.

- Dispor do setor de farmacotécnica, composto de unidades para:
 - manipulação de fórmulas magistrais e oficinais;
 - manipulação e controle de antineoplásicos;
 - preparo e diluição de germicidas;
 - reconstituição de medicamentos, preparo de misturas intravenosas e de nutrição parenteral;

- fracionamento de doses;
- análises e controles correspondentes;
- produção de medicamentos;
- outras atividades passíveis de serem realizadas segundo a constituição da farmácia hospitalar e as características do hospital.

- Elaborar manuais técnicos e formulários próprios.

- Manter membro permanente nas comissões de sua competência, em especial:

- na comissão de farmácia e terapêutica ou de padronização de medicamentos;

- na comissão de licitação ou parecer técnico;
- na comissão de suporte nutricional.

- Atuar na Central de Esterilização, para orientação de processos de desinfecção e esterilização de materiais, podendo mesmo ser responsável pelo setor.

- Participar dos estudos de ensaios clínicos e do programa de farmacovigilância do hospital.

- Exercer atividades formativas sobre materiais de sua competência, promovendo cursos e palestras e criando um Setor de Informações de Medicamentos, de acordo com as condições do hospital.

10. Estimular a implantação e o desenvolvimento da Farmácia Clínica.

- Exercer atividades de pesquisa, desenvolvimento e tecnologia farmacêuticas, no preparo de medicamentos e germicidas.

As responsabilidades da farmácia hospitalar, resumidamente, podem ser descritas como a gestão da assistência farmacêutica, gestão de produtos médico-hospitalares, implementação e monitorização de uma política interna de medicamento, gestão dos medicamentos empregados nos ensaios clínicos – se for o caso.

A SBRAFH (2017) resume as funções da farmácia hospitalar:

Na farmácia hospitalar e dos demais serviços de saúde, a provisão de produtos e serviços deve ser compreendida como meio, sendo a finalidade máxima do exercício de sua práxis o resultado da assistência prestada aos pacientes. Garantindo medicamentos seguros e necessários, quando estes são requeridos, visando sempre a efetividade da farmacoterapia e terapêutica geral, voltando-se também para o ensino e a pesquisa, propiciando assim um vasto campo de aprimoramento profissional. (SBRAFH, 2017).

De forma geral, a farmácia hospitalar tem responsabilidade sobre os pacientes, seus acompanhantes, e a todos os profissionais de saúde, garantindo informações e uma terapia medicamentosa segura e eficiência. Além de promover educação continuada aos que compõe seu quadro funcional e o do restante da instituição de saúde.



SAIBA MAIS:

A SBRAFH é a Sociedade Brasileira de Farmácia Hospitalar, que em ações conjuntas ao Conselho Federal de Farmácia, promove a normalização dos serviços farmacêuticos em farmácia hospitalar. Logo após a publicação da primeira resolução pelo CFF, em 1997, a SBRAFH publicou a primeira versão dos Padrões Mínimos para Farmácia Hospitalar. Essas orientações são atualizadas de tempos em tempos e a atualização mais atual foi em 2017, disponibilizada em:

<http://bit.ly/2EJTL2>

Complementando, segundo a Resolução do CFF n. 568, de 6 de dezembro de 2012, que dá nova redação aos artigos 1º ao 6º da Resolução/CFF nº 492 de 26 de novembro de 2008, que regulamenta o exercício profissional nos serviços de atendimento pré-hospitalar, na farmácia hospitalar e em outros serviços de saúde, de natureza pública ou privada, define-se que:

“Art. 2º - Os serviços de atendimento pré-hospitalar, farmácia hospitalar e outros serviços de saúde, têm como principal objetivo contribuir no processo de cuidado à saúde, visando à melhoria da qualidade da assistência prestada ao paciente, promovendo o uso seguro e racional de medicamentos - incluindo os radio-fármacos e os gases medicinais - e outros produtos para saúde, nos planos assistencial, administrativo, tecnológico e científico.

Art. 3º - No desempenho de suas atribuições nos serviços de atendimento pré-hospitalar, na farmácia hospitalar e em outros serviços de saúde, o farmacêutico exerce funções clínicas, administrativas, consultivas, de pesquisa e educativas”.

Ainda, para SBRAFH (2017), as funções da farmácia hospitalar se resumem em (...) funções clínicas, administrativas e consultivas, e a assistência farmacêutica deve ser desenvolvida em um setor interligado intrinsecamente aos demais.

As funções clínicas a assistência farmacêutica tem como foco o cuidado ao paciente e no atendimento de suas necessidades. Além disso, deve-se considerar o medicamento e os produtos para a saúde como instrumentos, sendo que o farmacêutico hospitalar deve estar envolvido em todas as fases da terapia medicamentosa.

Por sua vez, as atividades administrativas devem se galgar em práticas gerenciais que conduzam a processos mais seguros, permeados pelos conceitos de qualidade, valorizando a gestão de pessoas e processos, atendendo às normas e legislação vigentes no país.

A gestão dos serviços de farmácia deve, também, considerar o compromisso social e ambiental da farmácia. Além disso, as tomadas de decisão devem ser baseadas em informações e conceitos de farmacoeconomia, técnicas atuais e práticas de controle de custos, a fim de desenvolver ações economicamente viáveis e ambientalmente sustentáveis para a instituição hospitalar.

A Infarmed informa que a localização dos Serviços Farmacêuticos deverá obedecer sempre que possível os seguintes princípios:

- Facilidade de acesso externo e interno;
- Implantação de todas as áreas, incluindo os armazéns, no mesmo piso;
- O setor de distribuição de medicamentos a doentes ambulatoriais, se existir, deverá localizar-se próximo da circulação normal deste tipo de doentes, como por exemplo junto das consultas externas e ter entrada exterior aos serviços farmacêuticos;
- Proximidade com os sistemas de circulação vertical como elevadores.

Por fim, a gestão em serviços de farmácia deve ser feita por profissionais capacitados, com conhecimento, habilidades e atitudes para tomar as decisões corretas a fim de atender adequadamente os seus pacientes e a equipe multidisciplinar. Além disso, também com a missão de promover o uso racional de medicamentos e oferecer o melhor tratamento ao menor custo.

E, aí? Aprendeu tudo? Vamos dar uma revisadinha? Nessa competência nós exploramos a história da farmácia no Brasil e no Mundo. Vimos que inicialmente as carreiras de médico e de farmacêutico eram uma só e que ao longo do tempo foram separadas, como forma de "especialidade". No Brasil, essa história inicia-se com os índios, conhecimento que mais tarde combinaram-se aos dos imigrantes e dos povos africanos escravizados. Esses conhecimentos eram empregados para tratar a população comum, tendo em vista que o atendimento médico era permitido pela coroa somente aos portugueses. Com o tempo, as boticas ou herbanários foram abertos onde os profissionais eram responsáveis pelo diagnóstico, prescrição e manipulação do medicamento necessário. Com a industrialização da produção dos medicamentos, os farmacêuticos, então, buscaram outras formas de exercer a sua profissão. No âmbito hospitalar a presença do farmacêutico se tornou obrigatória, mesmo sendo a contragosto das demais profissões.

A farmácia hospitalar é definida como uma unidade clínico-administrativo integrada funcional e hierarquicamente ao organograma do hospital. Lá ele tem a exclusividade de ser o responsável técnico e deve fazer cumprir as funções da farmácia hospitalar que passaram a ser: garantir a qualidade da assistência prestada ao paciente por meio do uso seguro e racional de medicamentos e correlatos, de modo a adequar sua aplicação à saúde individual e coletiva com a finalidade assistencial, preventiva, docente e investigativo. Conseguiu se lembrar dos detalhes? Pronto para continuar?

Farmacêutico hospitalar: competências



INTRODUÇÃO:

Nessa competência iremos aprender sobre qual é o perfil do farmacêutico hospitalar, as habilidades e competências para assumir esse cargo. Devemos lembrar que da mesma forma que qualquer outro cargo, o farmacêutico hospitalar deve apresentar algumas características para que o indivíduo consiga cumprir os objetivos do seu cargo e contribua para cumprir o objetivo e as funções da farmácia hospitalar.

"As organizações são criadas para produzir algo: produtos ou serviços. Para tanto, utilizam energia humana e não-humana para transformar matérias-primas em produtos ou serviços. Embora possuam coisas inanimadas, como edifícios, máquinas e equipamentos, instalações, mesas, arquivos etc., as organizações são, afinal de contas, constituídas por pessoas." (CHIAVENATO, 2009, p. 7)

Chiavenato, dessa forma, nos deixa claro que as organizações não são o local de trabalho mas, sim, as pessoas que estão nele. De uma forma bastante genérica, não adianta ter paredes e computadores se não há um comando do ser humano que peça àquela matéria inanimada para fazer alguma coisa. Sobre o assunto o autor ainda coloca que:

"As organizações somente começam a funcionar quando as pessoas que devem cumprir papéis específicos e atividades solicitadas tenham ocupado suas posições correspondentes. Um dos problemas

básicos de toda organização consiste em recrutar, selecionar e formar seus participantes em função das posições de trabalho, de tal forma que cumpram seu papel com a máxima eficácia." (CHIAVENATO, 2009, p. 7-8)

Definições em gestão de pessoas

Como vimos o farmacêutico hospitalar tem a exclusividade para exercer o cargo de responsável técnico de serviços de farmácia hospitalar. Na farmácia hospitalar como qualquer outra organização depende de colaboradores com três características: conhecimentos, habilidades e atitudes. Assim, espera-se que o indivíduo apresente, em ambiente organizacional, competência no papel que exerce.

Mas, o que significa competência? Chiavenato (2009) explica que competência se refere ao conjunto de conhecimentos (saber), habilidades (como fazer), atitudes (querer fazer) e interesses que diferenciam as organizações ou pessoas em seu conjunto. Isso significa que determinadas pessoas apresentam determinadas características que se destacam mais do que outras. Essas características podem ser avaliadas e observadas quando essas pessoas são submetidas a determinadas situações, como em ambiente de trabalho, ou testes.

Carvalho et al (2014) explica que o conhecimento é obtido pelo farmacêutico por meio de um curso regular e aprovado pelo MEC de graduação em farmácia, realizar cursos extracurriculares, pós-graduações *lato* e *strictu sensu*, além de se manter atualizado, por meio de uma incessante por novas informações.

O autor ainda nos coloca que habilidade é quando o farmacêutico tem a capacidade de executar uma tarefa física ou mental, pois está relacionada à capacidade de transformar o conhecimento teórico em prática, de forma produtiva. Em outras palavras é o saber fazer, ou, ter *know-how* daquela atividade.

Por fim, atitude é relacionado ao próprio indivíduo, sua identidade pessoal e o que compõe seu temperamento e ideias. A atitude é aquilo que motiva o farmacêutico a colocar em prática as suas habilidades e conhecimentos. Em outras palavras, é o querer fazer.

Algumas palavras em gestão de pessoas parecem iguais, mas, na verdade, não são. Chiavenato (2009) nos esclarece as diferenças conceituais:

Tabela 2: Conceito e diferenciação dos termos aptidão, qualificação, capacitação e competência

Aptidão	Característica pessoal ou recurso inato ou desenvolvido pelo indivíduo.	Resistência física; Raciocínio matemático; Raciocínio lógico; Atenção para detalhes; Destreza manual
Qualificação	Educação: formal ou experiência profissional para exercer determinadas funções ou exercício de profissões.	Advogado Engenheiro Técnico Analista
Capacitação	Treinamento ou exercício profissional para executar determinadas atividades.	Executor; Operador; Digitado
Competência	Qualidade de quem é capaz de apreciar e resolver determinado assunto ou alcançar determinado objetivo ou resultado.	

Fonte: adaptado de Chiavenato, 2009, p. 17.

Para a definição do conjunto de habilidades e competências de determinada organização depende da cultura da organização, da estrutura organizacional da empresa, perfil profissional desejado para atender a demanda da organização, modo de avaliação de desempenho, a missão e filosofia da organização, o processo de identificação e avaliação das competências e a escolha da metodologia de avaliação das competências da organização.

O papel do farmacêutico hospitalar

O foco da farmácia hospitalar deve estar no paciente, utilizando o medicamento como instrumento para melhorar a sua qualidade de vida. No entanto, ela também deve desenvolver atividades relacionadas à gestão.

O perfil procurado pelo mercado de trabalho dos farmacêuticos hospitalares é mais gerencial, apesar de os profissionais não apresentarem essa característica, principalmente, devido a uma questão cultural e curricular da graduação em farmácia. Autores afirmam que o crescimento e evolução profissional depende de sua visão administrativa e empresarial.

Vamos relembrar rapidamente o conceito de farmácia hospitalar:

"Farmácia hospitalar - é a unidade clínico-assistencial, técnica e administrativa, onde se processam as atividades relacionadas à assistência farmacêutica, dirigida exclusivamente por Farmacêutico, compondo a estrutura organizacional do hospital e integrada funcionalmente com as demais unidades administrativas e de assistência ao paciente." (CFF,2012).

O farmacêutico hospitalar deve garantir aos doentes os medicamentos, produtos farmacêuticos e dispositivos médicos de melhor qualidade e aos mais baixos custos. A seleção, a programação, a aquisição, o armazenamento, a distribuição, a dispensação e o acompanhamento de medicamentos, produtos farmacêuticos e dispositivos médicos devem ocorrer sob a tutela de um farmacêutico. Essas ações são realizadas por meio de estudos fármaco-econômicos que, preferencialmente, não devem sofrer influência de preferências pessoais e não respaldadas em fatos científicos.

O fornecimento de informações sobre os medicamentos, insumos e produtos para saúde aos demais profissionais da saúde é de essencial (JULIANI, 2014). Essa disseminação de fatos é um meio importante para que se faça o uso racional dos medicamentos no ambiente hospitalar (ato), de modo a reduzir custos com escolhas inteligentes tendo em vista que os medicamentos são uma grande parcela dos gastos de um hospital.

Vale ressaltar a seguinte frase da Portaria nº 4283, de 30 de dezembro de 2010, do Ministério da Saúde:

"O gerenciamento inadequado e o uso incorreto de medicamentos e de outras tecnologias em saúde acarretam sérios problemas à sociedade, ao SUS, e às instituições privadas (hospitais, clínicas, operadoras de planos de saúde, entre outros), gerando aumento da morbimortalidade, elevação dos custos diretos e indiretos, e prejuízos à segurança e à qualidade de vida dos usuários."

Você se lembra que acabamos de falar sobre competência? Três itens são essenciais para se ter competência em algo: conhecimento, habilidade e atitude. Um truque para lembrar, use o acrônimo CHA. (Para tomar um CHA com a rainha é preciso de conhecimento, habilidade e atitude). O cargo do farmacêutico hospitalar não pode ser preenchido por qualquer um. O conhecimento mínimo necessário deve ser comprovado por meio de:

- Formação em curso de graduação contendo a disciplina de farmácia hospitalar com duração mínima de
- Prova de título emitido pela SBRAFH;
- Certificado de residência no âmbito hospitalar ou serviço de saúde; e,
- Certificado de curso de pós-graduação Lato Sensu reconhecido pelo MEC na área da Farmácia Hospitalar ou áreas afins relativas às atividades desempenhadas nos serviços de saúde.

É recomendável que o profissional busque atualizações ao menos a cada dois anos para que exerça suas atividades empregando as tecnologias mais atuais, utilizando a menor quantidade de recursos possível.

Além disso, é válido dizer que ao longo do tempo a tarefa do farmacêutico hospitalar necessitou cada vez mais de especializações na área clínica, para atuar em conjunto aos médicos e enfermeiros, além de outros profissionais de saúde, para auxiliar na escolha e no acompanhamento terapêutico dos pacientes. Conhecimentos sobre a farmacocinética, a farmacodinâmica, reações adversas, interações medicamentosas, participações em comissões hospitalares etc., foram aprofundadas em disciplinas ou cursos de farmácia clínica. A SBRAFH oferece o certificado em farmácia clínica aos farmacêuticos já certificados em hospitalar.

O profissional que seguir a carreira de farmacêutico hospitalar também deve apresentar algumas características que podem auxiliar em suas atividades. Essas qualidades na maioria das vezes são intrínsecas ao indivíduo e podem, ou não, serem afloradas por meio de treinamentos e mentorias. Dessa forma, seria correto dizer que as qualidades são sinônimo de atitudes. O CRF/SP em citação a OMS (1997) destaca sete qualidades que o farmacêutico deve ser:

- Capaz de tomar decisões;
- Comunicador;
- Líder;
- Gestor;
- Curioso; e,
- Educador.

As habilidades do farmacêutico além daquelas desenvolvidas e aperfeiçoadas no dia a dia do trabalho, também podem ser obtidas por meio de estágios e residências na área. Dessa forma, o profissional em formação consegue agregar conhecimento e aperfeiçoar as suas atitudes ao sair para o mercado de trabalho.

Considerando que o profissional agregue todos os requisitos necessários para ser um farmacêutico hospitalar está a postos para assumir as suas funções de gestor de serviços farmacêuticos. Suas funções ou atribuições são descritas por diversos autores, em primeiro lugar, iremos ver as descritas pelo Conselho Federal de Farmácia por meio da Resolução nº 568/2012 estabelece:

"Art. 4º - São atribuições do farmacêutico nos serviços de atendimento pré-hospitalar, farmácia hospitalar e outros serviços de saúde:

I. Do Serviço de Saúde;

II. Desenvolvimento de ações inseridas na atenção integral à saúde: - gerenciamento de tecnologias;

- Distribuição e dispensação;

- Manipulação;

- Gerenciamento de risco;

- Cuidado ao paciente.

III. Gestão da informação, infraestrutura física e tecnológica;

IV. Gestão de recursos humanos."

Complementando as atribuições do farmacêutico hospitalar, a SBRAFH (2017) apresenta como funções da farmácia hospitalar a gestão, o desenvolvimento de infraestrutura, logística farmacêutica e preparo de medicamentos, otimização da terapia medicamentosa, farmacologia

e segurança do paciente, informações sobre medicamentos e produtos para saúde e o ensino, educação permanente e pesquisa. Para tanto espera-se que o farmacêutico hospitalar apresente conhecimentos de administração, habilidade para coordenação e liderança, e sobre sistemas da qualidade.

Ao farmacêutico responsável-técnico, em particular, compete:

1. Cumprir e fazer cumprir a legislação atinente às atividades hospitalares e relativas à assistência farmacêutica.
2. Organizar, supervisionar e orientar tecnicamente todos os setores que compõem a farmácia hospitalar, assegurando-lhe as características básicas, bem como contribuindo para seu funcionamento em harmonia com o conjunto da unidade hospitalar.

Importante conceituar o que é um farmacêutico responsável técnico e para isso nós vamos viajar até a Resolução nº 577, de 25 de julho de 2013, do CFF que dispõe sobre a direção técnica ou responsabilidade técnica de empresas ou estabelecimentos que dispensam, comercializam, fornecem e distribuem produtos farmacêuticos, cosméticos e produtos para a saúde.

"Art. 1º – Para efeito desta resolução, são adotadas as seguintes definições:

I - FARMACÊUTICO DIRETOR TÉCNICO OU FARMACÊUTICO RESPONSÁVEL TÉCNICO - farmacêutico titular que assume a direção técnica ou responsabilidade técnica da empresa ou estabelecimento perante o respectivo Conselho Regional de Farmácia (CRF) e os órgãos de vigilância sanitária, nos termos da legislação vigente, ficando sob sua responsabilidade a realização, supervisão e coordenação de todos os serviços técnico-científicos da empresa ou estabelecimento, respeitado, ainda, o preconizado pela legislação laboral ou acordo trabalhista;"

As responsabilidades são grandes por isso tem que aprender tudo bonitinho! Por isso, está na hora da revisão.

Ao longo dessa competência aprendemos que competências envolvem pelo menos três características: conhecimento, habilidade e atitude. Para que um profissional seja um gestor de serviços farmacêuticos, ele deve buscar a formação em farmácia e residência ou especialização em farmácia hospitalar ou certificado em farmácia hospitalar pela SBRAFH. A residência, especialização ou certificado em farmácia hospitalar são necessários para aqueles que não possuem a formação generalista em um curso aprovado pelo MEC ou para aqueles que querem se aprofundar na área. As habilidades é o saber fazer que vem junto com a formação acadêmica, mas também com estágios e experiências profissionais. Por sua vez, as atitudes. Ahhh! Essas são quase sempre características do próprio indivíduo. Para o farmacêutico hospitalar espera-se que seja decidido, apresente características de líder, comunicador, educador, tenha conhecimentos técnicos e administrativos, ou seja, seja legitimamente um gestor. Por último, vimos as responsabilidades do responsável técnico que tem sob sua supervisão todas as atividades realizadas naquele estabelecimento, fazendo cumprir a legislação vigente. E, aí? Pronto para próxima? Vamos lá?

Conhecendo as atividades administrativas e clínicas dos serviços farmacêuticos



INTRODUÇÃO:

Ao término desta competência você conhecerá as atividades clínicas e administrativas dos serviços farmacêuticos. A importância da compreensão dessas atividades é para que você perceba o quanto é essencial a realização dessas atividades para o estabelecimento de saúde

Entendendo as atividades dos serviços de farmácia

Imagine que estamos em um ambiente vazio com muitas prateleiras, alguns computadores, mesas e cadeiras. Esse local fica dentro de um hospital pediátrico. O que deveria ter nas prateleiras para

atender adequadamente os pacientes? Que conhecimentos você deveria ter para assistir a esses pacientes e aconselhar os profissionais de saúde? Como escolher os medicamentos? O que fazer se o medicamento X é mais caro que Y, mas Y possui uma eficácia 10 vezes maior?

Agora, vamos imaginar que ao invés de um hospital geral com duas UTIs adulto, uma neonatal e uma pediátrica. Você acha que os medicamentos, insumos e correlatos que estavam no primeiro caso seriam iguais ou diferentes ao do primeiro caso?

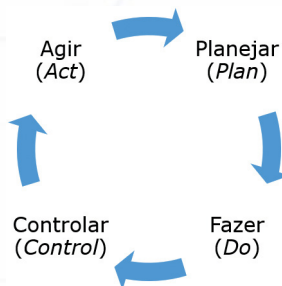
O foco da farmácia hospitalar deve estar no paciente e utilizar o medicamento e o conhecimento do farmacêutico como meio para melhorar a qualidade de e, quiçá, até mesmo a cura. Ao mesmo tempo, e quero dizer ao mesmo tempo MESMO, deve realizar atividades de gestão para que tudo deva sair dentro dos conformes.

Deve-se conhecer o macroambiente, isto é, é o complexo de condições e fatores externos que envolvem e influenciam todas as empresas em conjunto (variáveis tecnológicas, políticas, econômicas, legais, sociais, demográficas e ecológicas). Também o ambiente de tarefa que é aquele que a instituição toma para si, que engloba os clientes, fornecedores e concorrentes.

Por meio dessas informações, da política e objetivos se estabelece a estratégia empresarial que orienta o comportamento global do hospital, por exemplo, a longo prazo em relação ao ambiente externo.

A tarefa do gestor é interpretar os objetivos propostos pela instituição e transformá-los em ação. O modo como isso ocorre pode ser de várias formas, mas um dos mais conhecidos é o ciclo PDCA:

Figura 3. Ciclo PDCA



Fonte: a autora (2019)

O ciclo PDCA foi primeiramente elaborado por Walter Sheward na década de 20 e popularizado por William Deming – um dos papas da gestão da qualidade, na década de 50. Esse ciclo diz respeito a organização e execução dos processos de uma determinada instituição, no nosso caso, da farmácia hospitalar.

Essa teoria é mundialmente utilizada e, muitas vezes, é adaptada a outras realidades. Vamos ver rapidinho o que consiste em cada passo?

PLANEJAR: nessa fase o gestor junto aos seus diretores, seu presidente e, por vezes, os colaboradores e demais stakeholders estabelecem os objetivos para cumprir e superar as expectativas dos clientes. Não se pode esquecer que para que esses objetivos sejam factíveis as políticas da empresa devem ser levadas em consideração. O planejamento é dividido nos passos: identificação do problema, estabelecimento de metas, análise do fenômeno, análise do processo e estabelecimento de um plano de ação. Exemplo:

- Identificação do problema: como comprar produtos médico hospitalares de qualidade por licitação?

- Estabelecimento de metas: para os estabelecimentos de metas prefira empregar a ferramenta SMART, ou seja, que tem os atributos S (Específico), M (Mensurável), A (Atingível), R (Relevante) e T (Temporal). Exemplo de meta SMART: estabelecer 10 critérios de qualidade, em 5 dias úteis, para o produto médico hospitalar X para a construção da ficha de avaliação da amostra proveniente do pregão eletrônico.

- Análise do fenômeno: investigar as características específicas do problema com uma visão ampla e sob vários pontos de vista. Exemplo: Por que o material geralmente ofertado em licitações é de má qualidade? A descrição do produto no termo de referência está malfeita e deixa brechas ou o fornecedor é malandro e vende gato por lebre? Os editais preveem o encaminhamento de amostras? Se sim, como é feita a análise? A pessoa que recebe o produto conhece as especificações que deveria ter e que foi aprovado para isso?

- Análise do processo: descobrir as causas fundamentais. A partir das respostas até então obtidas listam-se as fundamentais. Pode-se empregar diagrama de Ishikawa, por exemplo, para auxiliar na obtenção de respostas.

- Plano de ação: estabelecer um plano para que as causas sejam bloqueadas ou minimizadas.

O diagrama de Ishikawa, causa e efeito ou espinha de peixe foi criado pelo engenheiro químico Kaoru Ishikawa em 1943. Ele relaciona o efeito (problema) com as causas que contribuem para seu acontecimento.

Inicialmente Ishikawa empregou 6 famílias de causas: método, material, mão de obra, máquina, medida e meio ambiente. Não se preocupe você pode adaptar a sua realidade. Após o estabelecimento das causas você pode, junto aos colaboradores envolvidos, fazer uma votação individual para as causas. Por exemplo: ao todo foram colocadas 9 causas, dessas nove cada um deve escolher 5 e numerá-la por ordem de importância.

Lembre-se de estabelecer um máximo de cinco causas para que o plano de ação seja mais exequível. Lógico que esse número pode mudar caso a caso.

- FAZER: trata-se do período onde o plano é efetivamente executado. No nosso exemplo vai desde a avaliação dos requisitos legais, a correta descrição no termo de referência, publicação do edital contendo a necessidade de amostra e o check list do que será avaliado na amostra, execução do pregão, recebimento da amostra, avaliação da amostra, aprovação do fornecedor, publicação do resultado, recebimento do produto, pagamento da nota e utilização do produto, obtenção da opinião dos profissionais sobre a usabilidade do produto.

- CHECAR: refere-se a analisar e verificar se aquilo que foi proposto no planejamento realmente foi feito. Se o que foi feito resolveu ou não o problema. Não à toa que a Portaria nº 4283/2010 do Ministério da Saúde refere-se quanto a gestão das farmácias hospitalares: "Para o acompanhamento das principais atividades da farmácia em hospitais, recomenda-se a adoção de indicadores de gestão, logísticos, de assistência ao paciente e de educação".

- AGIR: A partir dos resultados obtidos das etapas anteriores, desenvolve-se ações para melhorar ou "consertar" o processo para que os objetivos sejam atingidos eficientemente.

O PDCA é uma ferramenta para a melhoria contínua dos processos, conforme veremos a farmácia hospitalar apresenta diversos pequenos processos que contribuem para o bom funcionamento do processo total da farmácia.

De modo similar as etapas descritas do PDCA o ciclo da assistência farmacêutica também define a ordem de um conjunto de ações da farmácia clínica para o atendimento ao paciente.

Para falarmos sobre a atuação clínica do farmacêutico precisamos saber que essas atividades sempre existiram, mas com a implantação das políticas farmacêuticas na saúde pública pelo governo federal essa tarefa foi mais reconhecida. As políticas são "como um guia para direcionar o planejamento e a elaboração de estratégias, cujo desdobramento é um plano de ação, programas e projetos, para sua efetiva implementação" (BRASIL, 2006). Essas políticas consistiram na Política Nacional de Medicamentos e a Política Nacional de Assistência Farmacêutica.

A Política Nacional de Medicamentos foi aprovada, em 1998, e norteia todas as ações no que se trata os medicamentos no país. Algumas das suas diretrizes são: estabelecimento da RENAME (Relação Nacional de Medicamentos Essenciais), regulamentação sanitária, reorientação da Assistência Farmacêutica, promoção do uso racional de medicamentos, desenvolvimento científico e tecnológico, promoção da produção de medicamentos e garantia da segurança, eficácia e qualidade dos medicamentos.

Já, a Política Nacional de Assistência Farmacêutica foi aprovada em 2004 pela resolução 338 do Ministério da Saúde/ Conselho Nacional de Saúde é parte integrante da Política Nacional de Saúde, envolvendo um conjunto de ações voltadas à promoção, proteção e recuperação da saúde e garantindo os princípios da universalidade, integralidade e equidade.

A resolução 338/2004 estabelece que a Assistência Farmacêutica deve ser compreendida como política pública norteadora para a formulação de políticas setoriais, entre as quais destacam-se as políticas de medicamentos, de ciência e tecnologia, de desenvolvimento industrial e de formação de recursos humanos, dentre outras, garantindo a intersetorialidade inerente ao sistema de saúde do país (SUS) e cuja implantação envolve tanto o setor público como privado de atenção à saúde. Ainda, em seu artigo 1º:

" (...) III - a Assistência Farmacêutica trata de um conjunto de ações voltadas à promoção, proteção e recuperação da saúde, tanto individual como coletivo, tendo o medicamento como insumo essencial e visando o acesso e ao seu uso racional. Este conjunto envolve a pesquisa, o desenvolvimento e a produção

de medicamentos e insumos, bem como a sua seleção, programação, aquisição, distribuição, dispensação, garantia da qualidade dos produtos e serviços, acompanhamento e avaliação de sua utilização, na perspectiva da obtenção de resultados concretos e da melhoria da qualidade de vida da população; (...)" (BRASIL, 2004)

A Portaria nº 4283, de 30 de dezembro de 2010, do corrobora e complementa o conceito de 2004:

"(...) 3.5. Assistência Farmacêutica: trata de um conjunto de ações voltadas à promoção, à proteção e à recuperação da saúde, tanto individual como coletivo, tendo o medicamento como insumo essencial e visando ao acesso e ao seu uso racional. Esse conjunto envolve a pesquisa, o desenvolvimento e a produção de medicamentos e insumos, bem como a sua seleção, programação, aquisição, distribuição, dispensação, garantia da qualidade dos produtos e serviços, acompanhamento e avaliação de sua utilização, na perspectiva da obtenção de resultados concretos e da melhoria da qualidade de vida da população (...)"

O ciclo da assistência farmacêutica é composto da seguinte maneira:

Figura 5. Ciclo da assistência farmacêutica



Fonte: a autora (2019)

Em um paralelo ao ciclo PDCA podemos dizer que a seleção (padronização dos medicamentos e produtos para a saúde) e a programação refletem a etapa do planejamento. Já, a aquisição, armazenamento e distribuição podem ser considerados parte do "fazer". A dispensação por seu caráter orientativo e consultivo acaba por atuar como uma etapa de checagem pois é quando haverá o acompanhamento terapêutico propriamente dito. Por meio desse acompanhamento pode-se verificar se os medicamentos padronizados estão sendo efetivos para as situações que o hospital atende, por exemplo. Ou qual a incidência de reações adversas ou interações medicamentosas entre os pacientes.

Nesse contexto é importante sabermos o conceito de atenção farmacêutica que está intrinsecamente relacionado a terapia medicamentosa e seu acompanhamento.

"(...)IV - as ações de Assistência Farmacêutica envolvem aqueles referentes à Atenção Farmacêutica, considerada como um modelo de prática farmacêutica, desenvolvida no contexto da Assistência Farmacêutica e compreendendo atitudes, valores éticos, comportamentos, habilidades, compromissos e corresponsabilidades na prevenção de doenças, promoção e recuperação da saúde, de forma integrada à equipe de saúde. É a interação direta do farmacêutico com o usuário, visando uma farmacoterapia racional e a obtenção de resultados definidos e mensuráveis, voltados para a melhoria da qualidade de vida. Esta interação também deve envolver as concepções dos seus sujeitos, respeitadas as suas especificidades biopsicossociais, sob a ótica da integralidade das ações de saúde (...)" (BRASIL, 2004).

Imaginou como a cada tarefa técnica ou clínica há uma administrativa por trás? É... isso tudo está trançado, basta abrímos nossos olhos e mentes para enxergar além do que já estamos acostumados. Nesse sentido, o Sr. Albert Einstein um dia disse: "A mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original".

E então? Gostou do que te mostramos? Vamos arrematar todas as ideias dessa unidade e encerrar com a chave de ouro? Nessa unidade vimos o surgimento dos hospitais como centros de tratamento de enfermos, onde eram oferecidos toda a hospitalidade necessária. Vimos que o acesso a saúde era restrito a classes sociais altas ou àqueles que tinham posses e ao longo do tempo passaram a atender ao restante da população por meio de entidades filantrópicas como as Santas Casas da Misericórdia. Em 1988, no Brasil, com a promulgação da Constituição Federal, a saúde passou a ser direito de qualquer pessoa em território brasileiro e dever do Estado de ofertá-la adequadamente. Para isso, em 1990, o Sistema Único de Saúde entrou em vigor. Ao mesmo tempo da evolução da saúde pública, a profissão farmacêutica foi se alterando. No âmbito hospitalar a presença do farmacêutico se tornou obrigatória, onde exerce funções clínicas e administrativas e deve fazer cumprir as funções da farmácia hospitalar que passaram a ser: garantir a qualidade da assistência prestada ao paciente por meio do uso seguro e racional de medicamentos e correlatos. Para isso é necessário que tenha conhecimentos, habilidades e atitudes adequadas para o cargo. Por fim, vimos que os conhecimentos do profissional não devem restringir-se à assistência e atenção farmacêutica, mas que deve sempre estar aliada ao conhecimento administrativo.

BIBLIOGRAFIA

BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Assistência farmacêutica na atenção básica: instruções técnicas para sua organização Brasília: Ministério da Saúde, 2 ed., 2006.

BRASIL. Ministério da Saúde. Guia Básico para Farmácia Hospitalar. Brasília: Ministério da Saúde, 1994. Disponível em: <http://bit.ly/390Bckk>

BRASIL. CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE. 20 anos do SUS. Legislação. Disponível em: <http://bit.ly/2Shd86v>

BRASIL. MINISTERIO DA SAUDE. Resolução 338, de 06 de maio de 2004. Disponível em: <http://bit.ly/2Z8VogO>

CARVALHO, F. D. et al. Farmacêutico hospitalar: conhecimentos, habilidades e atitudes. São Paulo: Manole, 2014.

CAVALLINI, M. E.; BISSON, M. P. Farmácia Hospitalar: um enfoque em sistemas de saúde. São Paulo: Manole, 2 ed., 2010.

CHIAVENATO, I. Desempenho humano nas empresas: como desenhar cargos e avaliar o desempenho para alcançar resultados. São Paulo: Manole, 9 ed., 2009.

DANTAS, S. C. C. Farmácia e Controle das Infecções Hospitalares. Pharmacia Brasileira, n 80, fev./mar., 2011. Disponível em: <http://bit.ly/2Sa3G54>

JULIANI, R. G. M. Organização e funcionamento de farmácia hospitalar. São Paulo: Érica, 2014.

MÁLAGÓN-LONDOÑO, G. et al. Gestão Hospitalar para uma administração eficaz. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 4 ed., 2019.

SIMONETTI, V.M.M.; et al. Gestão de suprimentos da farmácia hospitalar com a implantação de métodos gerenciais de insumos utilizados na manufatura. Revista Eletrônica Produção Engenharia v.2 n.1 p. 57 68. Jan.-Jul, 2009.

SALU, E. J. Administração Hospitalar no Brasil. São Paulo: Manole, 2013.

Sociedade Brasileira de Farmácia Hospitalar (SBRAFh). Padrões Mínimos para Farmácia Hospitalar. São Paulo: SBRAFh, 3 ed., 2017. Disponível em: <http://bit.ly/2EIJTl2>

